

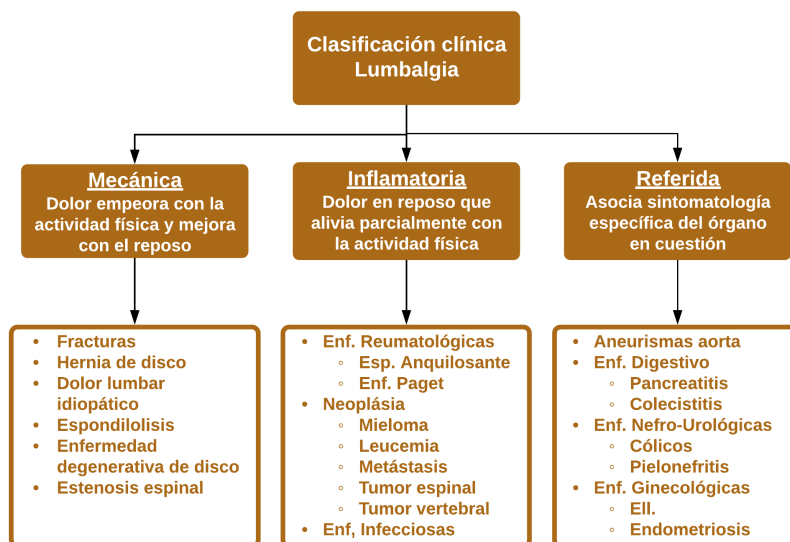
LUMBALGIA

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Dolor localizado en el dorso del cuerpo que se extiende desde la última costilla hasta la zona glútea y que puede irradiarse por el miembro inferior con una prevalencia del 80%.

Clasificación clínica de lumbalgia.



Clasificación según cronología

Aguda: Menos de seis semanas de duración.

Subaguda: Entre seis y doce semanas de duración.

Crónica: Más de doce semanas de duración.

DIAGNÓSTICO

Fundamentalmente clínico, aunque, cerca del 80% de las lumbalgias presentan hallazgos inespecíficos que no permiten llegar a una etiología concreta. La mayoría de las lumbalgias tienen un curso autolimitado en el tiempo (4-6 semanas) y son de naturaleza benigna.

Exploración física

- Inspección: estática del raquis, equilibrio hombros, miembros, crestas ilíacas y glúteos, valoración de la marcha, valoración de la movilidad lumbar.
- Palpación: de apófisis espinosas, musculatura paravertebral.
- Examen neuromuscular:
- Exploración sistémica.

Pruebas complementarias

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, PCR.
- **Sistemático y sedimento de orina.**
- **Radiología simple:** no de rutina, en general, indicada si sospechamos enfermedad sistémica, para descartar alteraciones estructurales importantes o si no hay mejoría tras 2-4 semanas de

tratamiento conservador.

- **TAC / RMN:** Según sospecha diagnóstica.

Datos de alarma

ENFERMEDAD SISTÉMICA	PARA VALORACIÓN POR CIRUGÍA
Lumbalgia inflamatoria.	Paresia progresiva o bilateral.
Primer episodio en <20 y >50 años.	Pérdida de control de esfínteres de origen neurológico.
Déficit neurológico difuso.	Anestesia en silla de montar.
Síndrome constitucional/ Inmunosupresión. Uso de corticoides y/o tóxicos por vía parenteral.	Dolor radicular que persiste ≥ 6 semanas a pesar de tratamiento conservador (probable hernia discal).
Antecedente de traumatismo/neoplasia/ manipulación instrumental.	Dolor radicular que requiere flexión/ extensión para desaparecer a pesar de 6 meses de tratamiento conservador.

Criterios de ingreso

- Mal estado general del paciente.
- Lumbalgia inflamatoria sin causa conocida a estudio.
- Lumbalgia mecánica que asocie clínica neurológica.
- Lumbalgia donde el tratamiento médico correcto haya fracasado para adecuado control del dolor.

TRATAMIENTO

Lumbalgia mecánica

Sin Compromiso Neurológico

Iniciamos con actitud conservadora como:

- Calor local (disminuye el espasmo), fisioterapia y reposo relativo con las que la mayoría remiten en 4-6 semanas. Si no respuesta, recurrimos a fármacos como:
- **Analgésicos** según escala de dolor, iniciar escala básica (paracetamol 650-1000 mg c/6-8 horas; Nolotil 575 c/6-8h).
- **AINEs** (dexibuprofeno 400mg c/12 horas, dexketoprofeno 25mg/8 horas; naproxeno 550 mg/12horas, diclofenaco 50mg 1 c/8 horas, etc).
- **Relajantes musculares** (Diazepam 5mg/24h o yurelax 10mg 1 c/24h preferentemente por las noches).
- **Corticoides** (Dexametasona 4mg/24 h tres días y luego otros tres a días alternos si no hay respuesta) y si refractariedad usaremos.
- **Analgésicos:**
 - **Opiodes menores:** tramadol 50 mg c/8h,etc.
 - **Opiodes mayores:** tapentadol 25 c/12h o 50mg C/12h ó 100mg C/12h según escala del dolor. Se pueden combinar con AINEs.

Con compromiso neurológico:

Considerar realizar RMN para valorar lesión y necesidad de cirugía según hallazgos.

Lumbalgia inflamatoria

Probable Espondiloartropatía

- AINE (Naproxeno 500 mg c/12h, etorocoxib 90 mg/24h) y derivación a Reumatología si buen estado general.
- Probable neoplasia: Ingreso hospitalario, estudio de imagen para tratar de identificar tumor

primario y valorar alcance de lesión (TAC-RMN-Gammagrafía).

Probable Infección

- Ingreso hospitalario, pruebas complementarias y tratamiento antibiótico IV dirigido.
- Sospecha de otras patologías: Valoración por especialista correspondiente.

NOTA

- La más frecuente es la lumbalgia mecánica, pero hemos de reconocer la inflamatoria por la gravedad que puede enmascarar.

BIBLIOGRAFÍA

- Donnay Brisa G., Jiménez Murillo L., Roig García J.J., Montero Perez F.J. Lumabalgia aguda. Lumbociatica. Medicina de Urgencias y Emergencias. 5 Edición. 2015. 105: 582-587.
- Sánchez Martín J. Lumabalgia Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital Universitario 12 Octubre. 7 Edición. 2015. 11:117-120.